

勃起功能障礙 (ED)

WARWIKI

病人須知 · 常見且可治療 — 同時係心血管健康嘅重要信號

勃起功能障礙 (ED) 係指難以勃起或維持足夠硬度去進行性行為，而且出現得夠頻繁，已構成困擾。ED 好常見，年紀愈大愈普遍 — 但係可以有效治療。因為勃起需要健康嘅血流，ED 亦可能係心血管疾病嘅早期警號，所以值得評估。

成因

勃起需要血管、神經、荷爾蒙同心理狀態共同配合。ED 通常有多於一個成因：

- **血流問題**（最常見）— 與心臟病共享風險因素：糖尿病、高血壓、高膽固醇、吸煙及體重過重。
- **神經問題** — 前列腺或盆腔手術後、糖尿病或脊椎疾病。
- **荷爾蒙問題** — 睪固酮偏低。
- **藥物與心理因素** — 某些藥物，加上壓力、焦慮、抑鬱或感情問題。

心血管健康檢查

陰莖嘅細小動脈往往最先顯示問題，所以新出現嘅 ED 係個好機會去檢查血壓、血糖同膽固醇 — 處理呢啲問題對你嘅心臟同勃起都有幫助。

詞彙解釋

勃起功能障礙 (ED)

難以勃起或維持足夠硬度進行性行為。

血管性

與血流有關 — ED 最常見嘅成因。

PDE5 抑制劑

第一線 ED 口服藥（西地那非、他達拉非等）。

真空勃起裝置 (VED)

一種將血液泵入陰莖令其勃起嘅裝置。

陰莖海綿體注射

自行注射藥物令陰莖勃起。

陰莖假體

當其他方法無效時使用嘅手術裝置。

可以治好嗎？ 幾乎都可以 — ED 係男性健康中最可治療嘅問題之一，由藥物到裝置到手術都有選擇。治療係一個階段：由簡單嘅方法開始，有需要先升一級，每個階段都有有效嘅選擇。

點樣治療（逐步）

- 1 **生活方式與健康管理** — 運動、減重、戒煙，以及控制糖尿病／血壓，確實可以改善勃起；同時檢視有否相關藥物影響。
- 2 **口服藥（PDE5 抑制劑）** — 通常係第一線治療。
- 3 **真空裝置、注射或尿道栓劑** — 如果藥物效果不足嘅有效選擇。
- 4 如睪固酮偏低可補充睪固酮；如有壓力或感情問題可考慮**心理輔導**。
- 5 **陰莖假體** — 當其他方法無效時可靠嘅手術選擇。每種方法都有獨立嘅病人資料。

點樣評估

- 問診（包括心血管風險因素及用藥史）同體格檢查
- 血液測試 — 血糖、睪固酮、膽固醇

重要提示

- 與伴侶坦誠溝通，以及處理情緒／焦慮問題，都大有幫助。
- 小心網上出售嘅未經證實「補充劑」— 部分含有隱藏藥物成分。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- ED 伴隨**胸痛**或運動時氣促 — 需要做心臟檢查
- ED 係**盆腔或陰莖受傷後突然出現**
- 治療後勃起持續**超過 4 小時**（緊急情況）

要記住嘅三件事

1. ED 非常常見且高度可治療，由藥物到假體，每個階段都有有效選擇。
2. ED 可能係心血管疾病嘅早期信號 — 評估有助整體健康，生活方式改善亦可改善勃起。
3. 主動同你嘅醫療團隊溝通。如 ED 伴有胸痛，或治療後勃起超過 4 小時，請即刻求醫。